Territorio de la Palabra
REVISTA ACADÉMICA DE PSICOLOGÍA
CARRERA DE PSICOLOGÍA · UAGRM
SANTA CRUZ DE LA SIERRA · BOLIVIA

Vol. 1, N.° 1 (2026) · pp. 79–87
CC BY-NC 4.0

ESTUDIO DE CASO · ESTUDIANTES

Procesos atencionales y de memoria en una niña con indicadores de inatención: estudio de caso

Attentional and memory processes in a girl with indicators of inattention: A case study

Gabriela Rosales[1]*

Tutor: PhD. Juan Jesus Justiniano

[1] Carrera de Psicología, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

* Correspondencia: gabriela.rosaless@icloud.com

RESUMEN

Objetivo. El presente estudio de caso describe los procesos atencionales y de memoria de una niña de 5 años y 11 meses evaluada por sospecha de dificultades de aprendizaje. Método. Se administró una batería de diez instrumentos cognitivos, proyectivos y atencionales. Resultados. Los resultados mostraron un funcionamiento intelectual general dentro del promedio y un rendimiento bajo en razonamiento analógico (Raven, percentil 5) y en atención perceptiva sostenida (Test de Caras, percentiles 15 a 20). La memoria visual diferida se situó en el percentil 50, rendimiento promedio, con una discrepancia de 30 puntos percentilares respecto de la copia (percentil 80). El cuestionario de ansiedad arrojó una puntuación directa de 17, interpretada por la evaluadora como nivel moderado. Conclusiones. El perfil es compatible con dificultades atencionales, pero una sola prueba de atención en una niña menor de seis años no permite sostener indicadores de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), cuyo diagnóstico requiere síntomas persistentes en dos o más contextos. A partir de los hallazgos se diseñó un plan de intervención lúdico-cognitiva, que no fue aplicado ni evaluado. Se concluye la importancia de una evaluación temprana y multimétodo para orientar la intervención en niños con dificultades atencionales.

Palabras clave: inatención; atención sostenida; memoria visual; evaluación psicológica; estudio de caso

ABSTRACT

Objective. This case study describes the attentional and memory processes of a 5-year-11-month-old girl assessed for suspected learning difficulties. Method. A battery of ten cognitive, projective, and attentional instruments was administered. Results. Results showed average ge-

neral intellectual functioning and low performance in analogical reasoning (Raven, 5th percentile) and in sustained perceptual attention (Faces Test, 15th to 20th percentile). Delayed visual memory fell at the 50th percentile, an average performance, with a 30-point percentile discrepancy relative to copy (80th percentile). The anxiety questionnaire yielded a raw score of 17, interpreted by the examiner as moderate. Conclusions. The profile is consistent with attentional difficulties, but a single attention test in a child under six does not support indicators of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), whose diagnosis requires persistent symptoms in two or more settings. Based on these findings, a play-based cognitive intervention plan was designed, which was neither implemented nor evaluated. The study highlights the importance of early, multimethod assessment to guide intervention in children with attentional difficulties.

Keywords: inattention; sustained attention; visual memory; psychological assessment; case study

RECIBIDO
30 de mayo de 2026

ACEPTADO
2 de octubre de 2026

PUBLICADO
30 de noviembre de 2026

CÓMO CITAR (APA 7)
Rosales, G. (2026). Procesos atencionales y de memoria en una niña con indicadores de inatención: estudio de caso. *Ñe Renda. Territorio de la Palabra, 1*(1), 79–87.

INTRODUCCIÓN

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por un patrón persistente de inatención, hiperactividad-impulsividad o ambas, que interfiere en el funcionamiento y se manifiesta en dos o más contextos; la presentación predominantemente con falta de atención corresponde a los casos en que predominan los síntomas de inatención (American Psychiatric Association [APA], 2022). Según Romero Pérez y Lavigne Cerván (2004), el trastorno se debe a una alteración neuropsicológica que provoca disfunciones en los mecanismos de control ejecutivo del comportamiento, afectando la atención sostenida, la memoria de trabajo, la autorregulación de la motivación y el afecto, la internalización del lenguaje y los procesos de análisis y síntesis. Esta caracterización procede del modelo de Barkley (1997), que propone un déficit primario de inhibición conductual del que dependerían cuatro funciones ejecutivas —memoria de trabajo, autorregulación del afecto, la motivación y la activación, internalización del lenguaje y reconstitución— y que el propio autor presentó como una teoría prometedora que requería más investigación.

En lo que respecta a la inatención, esta dificultad no es un constructo simple: se manifiesta como incapacidad para mantener la atención sostenida, seguir reglas e instrucciones y seleccionar estímulos relevantes frente a las distracciones. Desde una perspectiva neurobiológica, la hipótesis con más apoyo propone una disfunción en los circuitos frontoestriatales que afecta funciones ejecutivas como la me-

moria operativa y la integración temporal. A diferencia de los síntomas de hiperactividad, que suelen declinar con el desarrollo, la inatención muestra una notable estabilidad temporal y persiste con frecuencia en la adolescencia y la vida adulta (Carboni, 2011). No obstante, el metaanálisis de Willcutt et al. (2005), con 83 estudios, halló debilidades ejecutivas de tamaño moderado en los grupos con TDAH, pero no universales, por lo que concluyó que no son condición necesaria ni suficiente del trastorno: un rendimiento bajo en una prueba ejecutiva no basta para inferirlo.

El TDAH presenta una relación crítica con la memoria de trabajo, componente de las funciones ejecutivas encargado de almacenar y manipular información en tiempo real. Las deficiencias en este proceso se traducen en dificultades para seguir instrucciones, organizar tareas y mantener acciones dirigidas a objetivos, con impacto negativo en el rendimiento escolar y la adaptación (Venegas et al., 2018).

En el ámbito escolar, el TDAH se encuentra estrechamente vinculado al fracaso escolar, ya que sus síntomas de inatención afectan el rendimiento en diversas áreas académicas, especialmente matemáticas, lectura y escritura; el bajo rendimiento no suele reflejar la capacidad intelectual real del alumno, sino dificultades en las funciones ejecutivas y el control atencional (García Santana y Briones Palacios, 2023). Respecto a la evaluación temprana, Taboada y Pinto (2018) sostienen que la evaluación psicológica y neuropsicológica de niños con TDAH permite obtener un diagnóstico fidedigno que sirva de base para programas de rehabilitación cognitiva individualizados y evitar diagnósticos erróneos y tratamientos prematuros.

El objetivo del presente estudio fue describir los procesos atencionales y de memoria de una niña con sospecha de dificultades de aprendizaje y, a partir de ese perfil, proponer una intervención psicológica temprana.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Diseño

Estudio de caso único, descriptivo e interpretativo, con enfoque mixto: combina puntuaciones estandarizadas con observación conductual y análisis de producciones gráficas. El reporte sigue los elementos de la guía CARE aplicables a la evaluación psicológica.

Datos del caso

La participante es una niña de 5 años y 11 meses que cursa el primer grado de primaria en una unidad educativa de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La evaluación fue solicitada por la madre ante la sospecha de dificultades de aprendizaje. La niña no contaba con diagnóstico previo.

Consideraciones éticas

La evaluación fue solicitada por la madre de la niña ante la sospecha de dificultades de aprendizaje. La madre consiente de manera escrita tanto la evaluacion como la posterior publicacion salvaguardando la identidad de la menor. En el presente reporte se omitieron el nombre de la niña, el de la unidad educativa y cualquier otro dato que permita identificarla. No consta que el protocolo haya sido evaluado por un comité de ética, dado que el caso se originó como una valoración asistencial; esta ausencia se declara como limitación.

Técnicas

Se emplearon: (a) revisión de antecedentes escolares aportados por la madre; (b) observación conductual durante toda la administración, con registro del comportamiento, el nivel de atención y las reacciones, y (c) análisis integrado de los resultados de la batería. La evaluación se realizó de forma individual, en un ambiente tranquilo y sin distractores, en dos sesiones.

Instrumentos

Se administró una batería de diez instrumentos en dos momentos. En el primero se aplicaron siete pruebas cognitivas y proyectivas para evaluar visomotricidad, desarrollo intelectual, madurez, razonamiento lógico y mundo emocional-vincular. En el segundo, a partir de los resultados del primero, se aplicaron tres pruebas centradas en la atención, la memoria visual y la ansiedad (Tabla 1).

Tabla 1

Instrumentos administrados

Instrumento	Área evaluada	Momento	Función principal
Bender (sistema de Koppitz)	Visomotricidad	Primero	Maduración perceptivo-motora
Goodenough, Figura Humana	Inteligencia general	Primero	Madurez intelectual
Dibujo de la Figura Humana (Koppitz)	Madurez evolutiva	Primero	Ítems evolutivos e indicadores emocionales
Raven, Matrices Progresivas Coloreadas	Razonamiento	Primero	Razonamiento analógico no verbal
Machover	Área emocional	Primero	Indicadores proyectivos
Test de la Familia	Área emocional	Primero	Indicadores vinculares
H-T-P	Área emocional	Primero	Indicadores proyectivos casa-árbol-persona
Figura Compleja de Rey (figura A)	Memoria visual	Segundo	Copia y reproducción diferida
Test de Caras	Atención perceptiva	Segundo	Atención sostenida y selectiva
CAS	Ansiedad	Segundo	Nivel de ansiedad infantil

Nota. No se consignan los manuales ni los baremos de referencia de los instrumentos (véase Discusión, Limitaciones).

Procedimiento

El procedimiento se desarrolló en tres fases. En la primera se recabó información sobre el contexto escolar a través de la madre. En la segunda se administró la batería en dos sesiones individuales, comenzando por las pruebas cognitivas y proyectivas y continuando con las pruebas de atención, memoria y ansiedad. En la tercera se analizaron e integraron los resultados, se elaboró el informe y se diseñó el plan de intervención, que fue presentado a la familia. No se registraron la duración de las sesiones ni el orden de aplicación dentro de cada una.

EVALUACIÓN

La Tabla 2 sintetiza los resultados. En las pruebas de desarrollo intelectual general (Goodenough) y de madurez gráfica (DFH de Koppitz) la niña obtuvo resultados dentro del promedio para su edad, y la visomotricidad (Bender-Koppitz, PD = 9) se ubicó dentro de lo esperado.

En el Test de Matrices Progresivas de Raven la niña obtuvo un percentil 5 (rango V), por debajo de su rendimiento en las demás pruebas cognitivas. Durante su administración se registró una perseverancia irregular en la tarea.

En el Test de Caras obtuvo un índice de control de la impulsividad (ICI) de 62,5, con un rendimiento situado entre los percentiles 15 y 20, por debajo del promedio para su edad, y cometió 3 errores.

En la Figura Compleja de Rey obtuvo una puntuación bruta de 15,5 en la copia (percentil 80) y de 5 en la memoria diferida (percentil 50). Ambas puntuaciones se ubican en el rango normal; la diferencia de 30 puntos percentilares entre copia y memoria constituye una discrepancia intraindividual.

En el Cuestionario de Ansiedad Infantil (CAS) obtuvo una puntuación directa de 17, que la evaluadora interpretó como nivel moderado; el percentil se estimó solo de forma aproximada. En las técnicas gráficas se registraron, en el H-T-P, un árbol con tronco débil sin raíces y una casa con puerta pequeña sin línea de suelo, y en el Test de la Familia la omisión de la propia evaluada en el dibujo familiar.

Tabla 2

Síntesis de resultados de la evaluación

Instrumento	Puntuación	Nivel informado	Interpretación
Bender (sistema de Koppitz)	PD = 9	Promedio	Visomotricidad esperada para la edad
Goodenough	Sin elementos consignados	Promedio	Inteligencia general dentro de lo esperado
DFH (Koppitz)	Sin elementos consignados	Promedio	Madurez gráfica esperada

Instrumento	Puntuación	Nivel informado	Interpretación
Raven, Matrices Coloreadas	Pc = 5 (rango V)	Muy por debajo del promedio	Rendimiento bajo en razonamiento analógico (véase Discusión, Hipótesis rival)
Rey, copia	PD = 15,5; Pc = 80	Promedio alto	Buena organización perceptiva
Rey, memoria diferida	PD = 5; Pc = 50	Promedio	Retención visual promedio; discrepancia de 30 puntos respecto de la copia
Test de Caras	ICI = 62,5; Pc = 15–20	Por debajo del promedio	Atención perceptiva sostenida inferior a la esperada
CAS	PD = 17	Moderado (según la evaluadora)	Percentil exacto no informado

Nota. PD = puntuación directa; Pc = percentil; ICI = índice de control de la impulsividad.

Tabla 3

Análisis de contenido de los instrumentos del segundo momento

Contenido	Test de Caras	Figura de Rey	CAS
Comportamiento	Cooperativa, con dispersión atencional e impulsividad en la respuesta	Cooperativa; mayor concentración en la copia que en la memoria	Cooperativa, con tensión observable en algunos ítems
Aspectos intelectuales	Baja eficacia visoperceptiva y velocidad de procesamiento	Buena capacidad de copia; retención diferida promedio	Sin afectación intelectual directa
Aspectos orgánicos	Sin elementos significativos	Sin elementos significativos	Sin elementos significativos
Aspectos afectivos	Inseguridad y baja tolerancia a la frustración	Ansiedad ante tareas de mayor dificultad	Vulnerabilidad emocional
Área de conflicto	Atención selectiva y sostenida	Discrepancia copia-memoria	Ansiedad vincular y de rendimiento
Indicadores observados	Inatención de tipo perceptivo; impulsividad leve	Discrepancia copia-memoria sin déficit normativo	Nivel moderado según la evaluadora

Nota. Tabla de síntesis cualitativa elaborada por la evaluadora. Los indicadores observados no constituyen criterios diagnósticos.

DISCUSIÓN

Lectura general

La discrepancia entre el funcionamiento intelectual general y el rendimiento en atención perceptiva (Caras, percentiles 15 a 20) es coherente con lo señalado por Alava et al. (2021), quienes documentan que los niños con TDAH de presentación inatenta presentan dificultades en la atención sostenida y selectiva sin déficit intelectual global. Ese contraste es compatible con dificultades atencionales, pero no las especifica: en un caso evaluado con una sola prueba de atención, sin escalas de síntomas para padres y docentes y sin información de un segundo contexto, no se

cumplen los requisitos para plantear un TDAH (APA, 2022). Además, las debilidades ejecutivas no son condición necesaria ni suficiente del trastorno (Willcutt et al., 2005).

Hipótesis rival para el rendimiento en el Raven

El percentil 5 en el Raven contrasta con el rendimiento promedio en las demás pruebas cognitivas. La evaluadora lo interpretó inicialmente como una dificultad específica de razonamiento abstracto, pero consigna que durante esa prueba se observó una perseverancia irregular en la tarea. Cabe, por tanto, una hipótesis rival: el puntaje bajo podría ser consecuencia de la propia dificultad atencional y no una segunda dificultad independiente. La interpretación debe quedar en suspenso. Además, sostener la normalidad intelectual en la escala de Goodenough —una estimación gráfica de menor validez— y atribuir un déficit específico al Raven invierte la jerarquía psicométrica esperable. Una reevaluación del razonamiento con una prueba no verbal estandarizada, en condiciones de menor demanda atencional, permitiría discriminar entre ambas hipótesis.

Memoria visual y ansiedad

La memoria visual diferida se situó en el percentil 50, por lo que no puede hablarse de un compromiso de la memoria. La discrepancia de 30 puntos percentilares entre copia y memoria es un dato intraindividual que merece seguimiento, pero no un déficit. Venegas et al. (2018) describen alteraciones de la memoria de trabajo en niños con TDAH; la Figura de Rey en reproducción diferida evalúa la memoria visual a largo plazo, un proceso distinto, por lo que esa referencia no se aplica directamente a este resultado.

La puntuación del CAS fue interpretada como ansiedad moderada. Robles Bermejo (2024), en un estudio retrospectivo con 24 niños con TDAH sin tratamiento farmacológico, describió un perfil cognitivo dentro de la normalidad pero inferior al de los controles, y una alta frecuencia de trastornos específicos del aprendizaje asociados (58 %). La hipótesis de un círculo en el que la ansiedad reduce la capacidad atencional y los fracasos aumentan la ansiedad es plausible, pero no procede de esa fuente y no fue evaluada en este caso. Los indicadores gráficos —tronco débil, puerta pequeña, omisión de la propia figura en el dibujo familiar— podrían reflejar tensión emocional en el contexto vincular, pero se trata de signos aislados de validez limitada, sin acuerdo entre jueces ni corroboración independiente. Su lectura es una hipótesis que justifica una evaluación clínica complementaria, no una conclusión sobre la familia.

En el presente caso, la evaluación fue el primer acercamiento diagnóstico. Esto subraya la importancia señalada por Taboada y Pinto (2018) de evaluaciones psi-

cológicas tempranas y exhaustivas que permitan identificar perfiles de riesgo antes de que las dificultades se consoliden.

Propuesta de intervención

A partir del perfil se diseñó una propuesta de intervención de cinco sesiones semanales de dos horas, organizada en cinco ejes: (a) entrenamiento de la atención sostenida mediante discriminación visual progresiva y laberintos; (b) fortalecimiento de la memoria visual mediante secuencias, juegos de memoria y reproducción diferida; (c) estimulación del razonamiento lógico con matrices visuales, clasificación y deducción; (d) autorregulación emocional con herramientas psicoeducativas como el semáforo de emociones, la caja de calma y la respiración guiada, y (e) integración y consolidación de los aprendizajes. **La propuesta no fue aplicada ni evaluada**, por lo que su eficacia no ha sido establecida; su evaluación requeriría mediciones repetidas antes, durante y después de la intervención.

Implicaciones teóricas y prácticas

En el plano teórico, el caso ilustra por qué el modelo ejecutivo del TDAH (Barkley, 1997) no autoriza a inferir el trastorno a partir de un rendimiento bajo aislado: el mismo puntaje admite explicaciones atencionales, motivacionales o de procedimiento. En el plano práctico, sugiere que, ante sospechas tempranas de inatención, la evaluación debe incluir escalas de síntomas para padres y docentes, observación en más de un contexto y una lectura normativa cuidadosa de cada puntuación antes de orientar la intervención.

Limitaciones

El estudio no permite generalizar ni establecer relaciones causales. Además: (a) se empleó una sola prueba específica de atención; (b) no se recogió información de un segundo contexto (escuela) ni escalas de síntomas; (c) varias puntuaciones se informan de forma aproximada o sin percentil; (d) no se declaran manuales ni baremos de los instrumentos; (e) no consta la duración de las sesiones; (f) los indicadores proyectivos carecen de acuerdo entre jueces, y (g) el protocolo no fue evaluado por un comité de ética.

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio de caso muestran que la niña presenta un rendimiento por debajo del promedio en atención perceptiva sostenida y un rendimiento bajo en razonamiento analógico cuya interpretación queda en suspenso, porque puede deberse a la propia dificultad atencional. Su funcionamiento intelectual general es promedio y su memoria visual diferida es normal, con una discrepancia intraindividual respecto de la copia. Este perfil es compatible con difi-

cultades atencionales, pero no basta para plantear indicadores de TDAH. La ansiedad informada por la evaluadora es una dimensión emocional que conviene explorar con una evaluación clínica complementaria.

La evaluación temprana permitió identificar un perfil de riesgo antes de la consolidación de las dificultades, lo que representa una oportunidad de intervención. La propuesta de intervención lúdica y estructurada diseñada para el caso no fue aplicada ni evaluada; su eficacia deberá establecerse con mediciones repetidas.

Se recomienda continuar con el seguimiento psicológico, articular la intervención con la docente de aula y la familia, y derivar a psicología clínica para explorar los indicadores emocionales. La confirmación o el descarte de un TDAH requiere una segunda fase de evaluación con escalas de valoración de síntomas para padres y docentes (por ejemplo, las escalas de Conners) y con información de al menos dos contextos.

REFERENCIAS

Alava, S., Cantero García, M., Garrido Hernansaiz, H., Sánchez Iglesias, I., y Santacreu, J. (2021). Atención sostenida y selectiva en subtipos de TDAH y en trastorno de aprendizaje: Una comparación clínica. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, *19*(53). https://doi.org/10.25115/ejrep.v19i53.3778

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5.ª ed., texto rev.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425787

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, *121*(1), 65–94. https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.65

García Santana, S. L., y Briones Palacios, Y. M. (2023). Principales dificultades de aprendizaje en estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. *Revista Cubana de Educación Superior*

Robles Bermejo, F. (2024). Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Perfil neuropsicológico y estudio de su impacto en las funciones ejecutivas y académicas. *Anales de Pediatría*, *100*(2), 87–96. https://doi.org/10.1016/j.anpede.2024.01.004

Romero Pérez, J. F., y Lavigne Cerván, R. (2004). *Dificultades en el aprendizaje: Unificación de criterios diagnósticos* (Vol. 2). Junta de Andalucía, Consejería de Educación. https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO24885/dificultades_aprendizaje_2.pdf

Taboada, R., y Pinto, B. (2018). Evaluación neuropsicológica en dos niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad: Estudios de caso. *Ajayu*, *16*(1). https://app.lpz.ucb.edu.bo/publicaciones/ajayu/v16n1/v16n1_a04.pdf

Venegas, S., Fernanda, C., y López, M. (2018). Alteraciones de la memoria de trabajo en niños con trastorno de déficit atencional e hiperactividad: Qué nos dicen las neurociencias. *Revista Chilena de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia*

Willcutt, E. G., Doyle, A. E., Nigg, J. T., Faraone, S. V., y Pennington, B. F. (2005). Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review. *Biological Psychiatry*, *57*(11), 1336–1346. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2005.02.006

Este artículo se publica en acceso abierto bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).